TUMORES DE COLON, ANO Y RECTO

DR. EDGARDO ARCIA

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE COLON

- Estadio I: cirugía curativa sola. Estadio II: cirugía + quimioterapia adyuvante si hay factores de mal pronóstico. Estadio III: cirugía + quimioterapia adyuvante siempre.
- El estado de inestabilidad de microsatélites (MSI) es clave: los tumores MSI-alto responden mejor a inmunoterapia que a quimioterapia estándar.
- Enfermedad IV no resecable sintomática: cirugía paliativa (estoma o stent) + quimioterapia paliativa. Asintomática: solo quimioterapia paliativa.
- Oligometástasis resecable: cirugía del primario y de las metástasis (simultánea o en tiempos) con quimioterapia perioperatoria.

NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE COLON

- Tradicionalmente se operaba primero; estudios recientes exploran quimioterapia neoadyuvante en enfermedad localmente avanzada, sin aumentar el riesgo perioperatorio.
- Inmunoterapia neoadyuvante en tumores MSI-alto: tasas de respuesta patológica completa reportadas de hasta 68%.

SEGUIMIENTO EN WATCH & WAIT

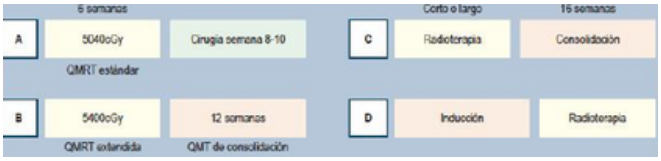
- Años 1–2: tacto rectal y sigmoidoscopia flexible cada 4 meses; RM cada 6 meses.
- Años 3–5: tacto rectal y sigmoidoscopia cada 6 meses; RM cada 12 meses.

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SANTO TOMÁS

- 2014–2017: 159 pacientes (84 laparoscópicos y 75 abiertos).
- Laparoscopia: más tiempo quirúrgico, menos sangrado y menor estancia; sin diferencia en cosecha ganglionar ni complicaciones Clavien-Dindo >2.

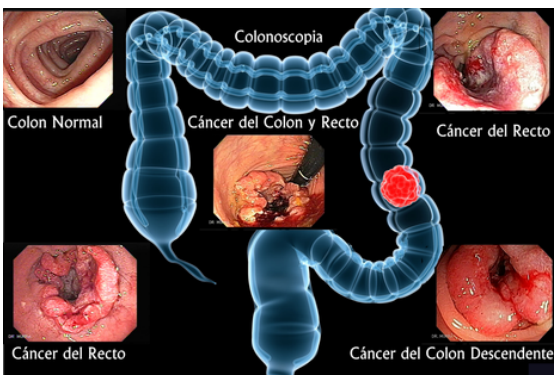
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO

- El manejo del cáncer de recto localizado ha evolucionado hacia la terapia neoadyuvante total (TNT): quimioterapia y radioterapia completas antes de la cirugía.
- La TNT mejora la adherencia al tratamiento comparado con dar la quimioterapia después de la cirugía, ya que muchos pacientes no completaban la adyuvancia posoperatoria.



MANEJO NO OPERATORIO

- En pacientes con respuesta clínica completa tras la neoadyuvancia, se puede optar por observación estrecha en vez de cirugía inmediata.
- La base de datos internacional de Watch & Wait muestra supervivencia similar entre respuesta clínica y patológica completa (87.9% vs 87.6% a 5 años).
- ~25% presenta recrecimiento tumoral en los primeros 2 años, casi siempre localizado en la pared intestinal y rescatable con cirugía.
- Esta estrategia ofrece mejor calidad de vida al evitar una cirugía mayor y una posible ostomía permanente.



TUMORES DE COLON, ANO Y RECTO

DR. EDGARDO ARCIA

PROBLEMA DEL ESTADIO III
- Algunos pacientes se curan con cirugía y se sobretratan con QT; otros recurren pese al manejo estándar.
- Necesidad: mejor selección para la adyuvancia y nuevas estrategias.

METAANÁLISIS DE QT NEOADYUVANTE
- 7 estudios, 2120 pacientes con cáncer de colon localmente avanzado.
- Supervivencia global a 5 años: 79,9% vs 72,6%; libre de enfermedad: 73,1% vs 64,5%.
- Sin mayor riesgo perioperatorio.

SENSIBILIDAD DE LA RADIOLOGÍA
- Estadificación T: concordancia del 60%; N: 54,1%; invasión extramural: VPP 50,7%.

ADHERENCIA A LA ADYUVANCIA EN RECTO
- Con el esquema adyuvante clásico solo hubo 43% de adherencia y 28% no recibió el tratamiento; base de los estudios de TNT (RAPIDO, PRODIGE-23).

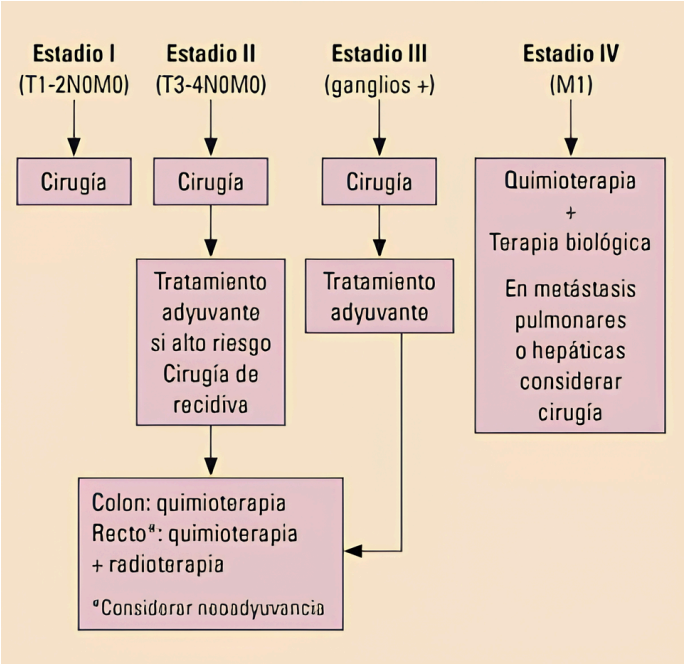
ENSAYO OPRA
- TNT con QT de inducción vs consolidación en recto T3-4 o N+ (n = 324).
- Reestadificación con tacto, endoscopia, RM de pelvis y TC: respuesta completa → Watch & Wait; incompleta → cirugía (TME).
- SLP a 3 años similar operando tras reestadificación o tras recrecimiento (65% vs 60%).

INMUNOTERAPIA EN RECTO dMMR
- Dostarlimab neoadyuvante (MSKCC) en estadios II–III con dMMR: 100% de respuesta clínica completa, sostenida a 12 meses.

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE ANO
- VPH, verrugas genitales, relaciones sexuales anales, tabaquismo e inmunosupresión.

CLÍNICA DEL CÁNCER DE ANO
- Sangrado, dolor o presión anal, masa, picazón o secreción y cambios del hábito intestinal.
- Diagnóstico: examen físico y rectal, anoscopia, biopsia, TC o RM.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ANO
- Radioterapia a menudo combinada con quimioterapia.
- Cirugía: resección local o amputación abdominoperineal en casos avanzados.



CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO
- Resección transanal, resección anterior baja o amputación abdominoperineal según la localización y el estadio.

CÁNCER DE RECTO ESTADIO IV
- No resecable sintomático: cirugía paliativa (estoma o stent) + QT y/o RT paliativa.
- No resecable asintomático: QT paliativa.
- Oligometastásico resecable: neoadyuvancia, cirugía del primario y de las metástasis, QT antes y después.

ASPECTOS ONCOLÓGICOS DEL CIRUJANO
- Márgenes, cosecha ganglionar, ligadura del pedículo vascular y escisión del meso.

COLECTOMÍAS SEGÚN LA UBICACIÓN
- Hemicolectomía derecha y derecha extendida; colectomía del transverso, del descendente, del sigmoides y subtotal.

ASPECTOS TÉCNICOS
- Anastomosis intracorpórea vs extracorpórea; puerto único vs multipuerto; cirugía robótica.
- Prueba neumática de la anastomosis: 7,9% positivas; sin fugas con estoma protector o reanastomosis vs 12,2% si se reparaba con sutura.
- Fluorescencia: perfusión (cambió la conducta en 8%), uréteres y linfadenectomía.